可能可能最可能：长期咳**大量脓痰**、多**咯血**，**麻疹/百日咳/肺结核**等病史；干性支扩反复咯血、在肺上叶尖后段

《诊断学》：杵状指见于**肝硬化**、系统性硬化症、**支扩**、**间质性肺病**、**亚心炎**、**炎症性肠病**、**慢性肺脓肿**、慢性脓胸、梅毒、法洛四联症、**肺癌**（硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎）

肝肾综合征,肝肺综合征(缺氧)　需要时间　肠外表现




四、治疗

1.针对脓痰：清除分泌物

渗透压高吸水稀释

①雾化吸入高渗生理盐水或乙酰半胱氨酸 祛痰药

②体位引流：头低臀部抬高 利用重力

③排痰**不宜过快**以防窒息

2.针对咯血　包括抗利尿激素(大剂量收缩血管)、缩宫素-内科医生止血钳

①量中：垂体后叶素或酚妥拉明→ 阻断血管α1-R扩血管-降低肺动脉压力,减少出血　适合咯血伴肺心病/高血压者

②**量大**（**＞500ml/d 或＞100ml/次**五一）：病变**弥漫**→**介入栓塞支气管动脉**；病变**局限**→**手术**切除　支气管静脉一般是左心衰的问题

支扩/肺癌大咯血均用此治疗方法　营养血管VS 肺A是功能血管

3.针对支扩**合并急性感染**：抗感染

①**发热**、痰量增多及脓性成分增加 小凯笔记助记 一般规律:头孢代数↑,针对G-越强,针对G+越弱(阴盛阳衰)

②无铜绿假单胞菌感染高危因素：针对**流感嗜血杆菌**，用氨苄西林、阿莫西林、二三代头孢、呼吸喹诺酮类（流感怎么治？按摩二三下头盔）　广谱青霉素

③有**铜绿假单胞菌**感染高危因素（按头窥探）

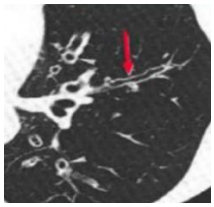
近期**住院**、严重气流阻塞 **FEV_1＜30%预计值** 每年 4 次以上或近 3 个月内用抗生素、近 2 周口服泼尼松＞10mg/d	
氨基糖苷类	妥布霉素 庆大霉素肾毒性耳毒性太严重,一般不用
β 内酰胺类	**头孢他啶/哌酮/吡肟**等**三四代**头孢、哌拉西林-他唑巴坦（ttsx 他坐着排稀）
呼吸喹诺酮类	环丙**沙星**、左氧氟沙星（不选诺氟沙星懦夫）诺氟沙星主要针对消化道
碳青霉烯类	亚胺**培南**、美罗培南（不选厄他培南恶心）铜绿假单胞菌对厄他培南耐药

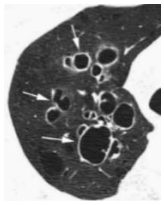
β内酰胺类无头孢曲松（不选头孢曲松）

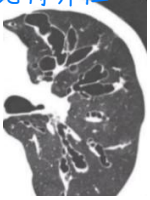
五、金标准检查-HRCT

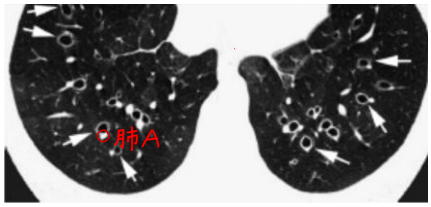
支扩的影像学表现多样：多发**薄壁囊腔**（囊状扩张）、**管壁增厚**呈**双轨征**（柱状扩张），部分见液平，印戒征、**卷发征**、串珠征、蜂窝征

扩张的支气管(直径超过肺A)和伴行的肺A　无特异性

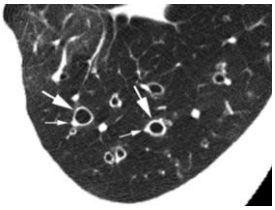

柱状扩张


囊状扩张


串珠征



印戒征


VS印戒细胞癌(产生大量黏液潴留在胞内把胞核挤向一侧)